DIRECTIVA N° 001- 2025-SIS/GREP - V.01

DIRECTIVA QUE REGULA LA AUDITORÍA DE SEGUROS DE LAS PRESTACIONES DE SALUD BRINDADAS POR LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD QUE CUENTAN CON CONVENIO O CONTRATO CON EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)

	ÓRGANO	FIRMA Y SELLO
Elaborado por	Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones	Firmado digitalmente por CARPIO MONTENEGRO Wilder Vidauro FAU 20505208626 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 01.09.2025 18:25:52 -05:00
Revisado por	Oficina General de Tecnología de la Información	Firmado digitalmente por GUTIERREZ REYES Miguel Angel FAU 20505208626 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 02.09.2025 09:09:43 -05:00
Revisado por	Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Organizacional.	Firmado digitalmente por KAHN SEGURA Maria Matilde FAU 20505208626 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 02.09.2025 09:47:55 -05:00
Revisado por	Oficina General de Asesoría Jurídica	Firmado digitalmente por CHÁVARRY CORREA Alcides Pelayo FAU 20505208626 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 02.09.2025 10:07:02 -05:00
Revisado por	Secretaría General	Firmado digitalmente por DE LA FLOR MATOS Manuel Roberto FAU 20505208626 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 04.09.2025 15:17:14 -05:00
Aprobado por	Jefatura del SIS	Firmado digitalmente por QUIROZ AVILES Luis Napoleon FAU 20505208626 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 04.09.2025 16:34:39 -05:00

DIRECTIVA QUE REGULA LA AUDITORÍA DE SEGUROS DE LAS PRESTACIONES DE SALUD BRINDADAS POR LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD QUE CUENTAN CON CONVENIO O CONTRATO CON EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)

I. FINALIDAD

Garantizar que las prestaciones de salud brindadas a los asegurados del Seguro Integral de Salud cumplan con las condiciones de calidad de los servicios de salud, en el marco de los convenios o contratos suscritos; así como, prevenir la ocurrencia de prestaciones indebidas

II. OBJETIVO

2.1 Objetivo General

Establecer las disposiciones para la ejecución de la auditoría de seguros que realiza el Seguro Integral de Salud a las IPRESS públicas, privadas o mixtas, en el marco de los convenios o contratos suscritos, que permita verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones referidas a las prestaciones de salud otorgadas a los asegurados del Seguro Integral de Salud.

2.2 Objetivo Específicos

2.2.1 Implementar y normar el proceso de Auditoría Automatizada.
2.2.2 Implementar y normar el proceso de Auditoría de Pertinencia.
2.2.3 Implementar y normar el proceso de Auditoría Presencial.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para todos los órganos del pliego del Seguro Integral de Salud a nivel nacional y para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas, privadas o mixtas en lo que corresponda, en el marco de los convenios o contratos vigentes suscritos con el SIS.

IV. BASE LEGAL

4.1. Decreto Legislativo N°1163, Decreto Legislativo que Aprueba Disposiciones para el Fortalecimiento del Seguro Integral de Salud y sus modificatorias.

4.2. Decreto Supremo N°030-2014/SA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1163 que aprueba disposiciones para el fortalecimiento del Seguro Integral de Salud y sus modificatorias.

4.3. Resolución de Superintendencia N° 004-2020-SUSALUD/S, que aprueba las Cláusulas mínimas de los contratos o convenios suscritos entre las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), o las Unidades de Gestión de IPRESS (UGIPRESS).

4.4. Los convenios y contratos vigentes suscritos entre el Seguro Integral de Salud, el Fondo Intangible Solidario de Salud, y Gobierno Regionales, Direcciones de Redes Integradas de Salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, para el financiamiento de prestaciones a asegurados SIS.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Acrónimos

- **ASECO** : Auditoría de seguros y de control
- **CIE** : Clasificación Internacional de Enfermedades
- **DIRIS** : Dirección de Redes Integradas de Salud
- **DIRESA** : Dirección Regional de Salud
- **FISSAL** : Fondo Intangible Solidario de Salud
- **FUA** : Formato Único de Atención
- **GERESA** : Gerencia Regional de Salud

- **GMR** : Gerencia Macro Regional
- **GREP** : Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones
- **IA** : Inteligencia Artificial
- **IAFAS** : Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud
- **IPRESS** : Institución Prestadora de Servicios de Salud
- **MINSA** : Ministerio de Salud del Perú
- **OGTI** : Oficina General de Tecnología de la Información
- **PAA** : Proceso de la Auditoría automatizada
- **PAP** : Proceso de la Auditoría de pertinencia
- **PEAS** : Plan Esencial de Aseguramiento en Salud
- **PNUME** : Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales
- **SIGEPS** : Sistema de Información de Gestión de Prestaciones de Salud.
- **SIS** : Seguro Integral de Salud
- **UE** : Unidad Ejecutora
- **UDR** : Unidad Desconcentrada Regional
- **UGIPRESS** : Unidad de Gestión de la IPRESS.

5.2. Definiciones

Para efectos de la presente Directiva, se utilizan las siguientes definiciones:

5.2.1. Aplicativos informáticos del SIS

Los aplicativos informáticos, son un tipo de programa informático diseñado o adquirido como herramienta, para permitir a los usuarios realizar uno o diversos tipos de

trabajo. Estos aplicativos tienen como principal objetivo, facilitar a los usuarios internos y externos el registro de información.

5.2.2. Asegurado/afiliado

Toda persona residente en el país, que está bajo la cobertura financiera en alguno de los regímenes de financiamiento de la IAFAS SIS

5.2.3. Auditor de seguros

Es el médico auditor o profesional de salud capacitado en Auditoría de seguros acorde a sus competencias, quien realiza actividades relacionadas con Auditoría de seguros para el SIS.

5.2.4. Auditoría de seguros

Es el procedimiento objetivo, sistémico y ordenado que evalúa y verifica la correcta prestación de servicios según los planes/contratos de cobertura del asegurado, estado de acreditación o condición de la entidad empleadora.

5.2.5. Código de Inconsistencia

Es el código que identifica el incumplimiento de un criterio en una regla de consistencia.

5.2.6. Código de Observación

Es el código que identifica el incumplimiento de un criterio en una regla de validación.

5.2.7. Formato Único de Atención (FUA)

Es el instrumento en el que se registran y acreditan, en físico o en medio magnético, los datos requeridos por el SIS sobre las prestaciones asistenciales y/o administrativas, como los del asegurado que la recibe. Se caracteriza por contener una numeración única que lo identifica y se utiliza como fuente de información para los registros informáticos del SIS, así como para los procesos de auditoría o de validación prestacional. El FUA (físico o electrónico) tiene carácter de declaración jurada.

5.2.8. Historia Clínica

Es el documento médico legal, en el que se registra los datos de identificación y de los procesos relacionados con la atención del paciente, en forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata a la atención que el médico u otros profesionales de salud brindan al paciente o usuario de salud y que son refrendados con la firma manuscrita o electrónica de los mismos. Las historias clínicas son administradas por las IPRESS.

5.2.9. Historia clínica Electrónica:

Es la Historia clínica registrada en forma unificada, personal, multimedia; refrendada con la firma electrónica del médico u otros profesionales de salud, cuyo tratamiento (registro, almacenamiento, actualización, acceso y uso) se realiza en estrictas condiciones de seguridad, integralidad, autenticidad, confidencialidad, exactitud, inteligibilidad, conservación y disponibilidad a través de un Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas, de

conformidad con las normas aprobadas por el Ministerio de Salud, como órgano rector competente[1].

5.2.10. Firma electrónica:

Es aquella firma electrónica que utilizando una técnica de criptografía asimétrica, permite la identificación del signatario y ha sido creada por medios, incluso a distancia, que garantizan que este mantiene bajo su control con un elevado grado de confianza, de manera que está vinculada únicamente al signatario y a los datos a los que refiere, lo que permite garantizar la integridad del contenido y detectar cualquier modificación ulterior, tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita, siempre y cuando haya sido generada por un Prestador de Servicios de Certificación Electrónica debidamente acreditado que se encuentre dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, y que no medie ninguno de los vicios de la voluntad previstos en el Titulo VIII del Libro IV del Código Civil.

5.2.11. Machine Learning

Es una aplicación de la inteligencia artificial que proporciona a los sistemas la capacidad de aprender y mejorar automáticamente de la experiencia, sin requerir programación, el aprendizaje automático se enfoca en el desarrollo de programas informáticos que puedan acceder a los datos y los utiliza para aprender por sí mismos.

---

[1] Resolución Ministerial N° 164-2025-MINSA, aprueba la Directiva Administrativa N° 333 - MINSA/OGTI-2025, “Directiva Administrativa que establece el proceso de acreditación de los Sistemas de Información de Historias Clínicas Electrónicas"

El proceso de aprendizaje comienza con la revisión del registro del FUA de periodos anteriores para identificar no conformidades y analizar su comportamiento. Luego, se selecciona un algoritmo de clasificación, que se ajusta con estos datos para que aprenda a reconocer patrones. Una vez ajustado, el modelo se aplica a nuevos datos con el objetivo de detectar no conformidades y mejorar la toma de decisiones en el futuro.

5.2.12. Muestra de prestaciones a auditar

Conjunto de prestaciones de salud seleccionados previamente y conforme a criterios preestablecidos para ser evaluados por el auditor SIS en el proceso de Auditoría Asistida por Machine Learning y Auditoria electrónica de prestaciones.

5.2.13. Período de Producción

Lapso de tiempo durante el cual se puede registrar datos en los aplicativos informáticos del SIS, sobre las prestaciones de salud brindadas a los asegurados del SIS, en el marco de los convenios o contratos suscritos, que será asignado a un mes de producción.

5.2.14. Plan de Beneficios de la IAFAS SIS

Es el listado de beneficios asociados a un seguro de salud del régimen de financiamiento subsidiado o semicontributivo administrado por la IAFAS SIS, que brinda la cobertura financiera de las prestaciones de salud o administrativas, acorde a su Plan de Seguro.

5.2.15. Prestaciones Observadas

Son aquellas prestaciones de salud registradas en la base de datos del SIS que, tras la aplicación de Auditoría automatizada y la Auditoría electrónica de las prestaciones no cumplen parcial o totalmente los criterios establecidos en la normatividad vigente.

5.2.16. Prestaciones Rechazadas

Son aquellas prestaciones de salud registradas que posterior a la Auditoría de seguimiento y Auditoría asistida por Machine Learning incumplen los estándares establecidos en las normas técnicas, protocolos de atención, guías de práctica clínica y otro documento normativo vigente. Esta situación implica que la prestación no será reconocida para efectos de pago.

5.2.17. Prestaciones Reconsideradas

Es el resultado de la Auditoría de seguimiento mediante el cual se verifica que el prestador ha cumplido con sustenta de manera adecuada las prestaciones observadas cumpliendo los estándares establecidos en las normas técnicas, protocolos de atención, guías de práctica clínica, u otros documentos normativos. Estas prestaciones son consideradas válidas para el financiamiento de acuerdo con el mecanismo de pago predefinido.

5.2.18. Prestaciones de Salud

Son atenciones de salud otorgadas a los asegurados SIS en forma presencial o por telemedicina en las IPRESS de acuerdo a su categoría y cartera de servicios. Pueden ser prestaciones promocionales, preventivas, recuperativas,

paliativas y de rehabilitación, se desarrollan de forma intramural y extramural.

5.2.19. Reglas de Consistencia

Criterios de registro de las prestaciones de salud que actúan como filtros de control para permitir el ingreso de datos en los aplicativos informáticos del SIS. Estas reglas son de dos tipos: inmediata y mediata.

a. Reglas de consistencia inmediata: son las reglas que actúan durante el registro de la prestación en los aplicativos informáticos el SIS, y de no ser superadas no permiten grabar la prestación.
b. Reglas de consistencia mediatas: son las reglas que se aplican de forma posterior a la digitación.

5.2.20. Reglas de Control de Registro

Son parámetros mínimos de registro que actúan como un filtro de control para permitir el ingreso de las prestaciones de salud en los aplicativos informáticos del SIS. Sus resultados no implican la superación de Reglas de Consistencia

5.2.21. Reglas de Validación

Son criterios técnicos que verifican el cumplimiento del adecuado registro, estándares de calidad de atención, oportunidad e integralidad de acuerdo con la normatividad vigente que deben cumplir las prestaciones financiadas por el SIS.

5.2.22. Seguridad de la Información

Es el conjunto de acciones para preservar la

confidencialidad, intangibilidad, integridad y disponibilidad de la información, además, de otras características como la autenticación, responsabilidad, no repudio y fiabilidad.

5.2.23. Telemedicina

Provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, recuperación o de rehabilitación prestados por personal de salud que utiliza tecnología de la información y de la comunicación (TIC), con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de salud a la población.

5.2.24. Valores Atípicos

FUA de costo elevado según valores referenciales por código de servicio que, se obtienen mediante algoritmos automatizados previo a la auditoria electrónica de prestaciones.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1 De la Auditoría de seguros y de control de las prestaciones de salud (ASECO)

Es el conjunto estructurado de procedimientos interrelacionados que trabajan de manera coordinada a fin de verificar que las prestaciones de salud brindadas por las IPRESS cumplan con las condiciones acordadas en los convenios o contratos suscritos, con el objetivo de garantizar la estabilidad operativa, proteger los derechos de los asegurados y cumplir con las regulaciones del sector.

6.2 La ASECO comprende tres procesos de auditoría:

1. Proceso de Auditoría Automatizada (PAA).
2. Proceso de Auditoría de Pertinencia (PAP).
3. Proceso de Auditoría Presencial (APRE).

6.3 **Proceso de la Auditoría Automatizada (PAA):**

Es la Auditoría que se ejecuta mediante la aplicación de algoritmos informáticos integrados en los aplicativos informáticos del SIS, en los cuales se registran los datos relativos a las prestaciones de salud otorgadas a los asegurados del SIS. Comprende la utilización de reglas de control de registro (RR), reglas de consistencia (RC) y reglas de validación (RV), las cuales se aplican e integran como algoritmos informáticos de forma sistemática a toda la producción registrada en los aplicativos informáticos del SIS, con el fin de verificar la calidad, integridad y coherencia de los datos; y permitir su registro en la base de datos del SIS.

6.3.1 Aplicación de Reglas de Control de Registro (RR): Son las reglas que se aplican durante el registro de la información de la producción en los aplicativos informáticos del SIS. Estas reglas se implementan con el objetivo de facilitar el control de calidad de los datos ingresados, asegurando su completitud y formato adecuado, y preparando la información para la posterior aplicación de las reglas de consistencia (RC).

6.3.2 Aplicación de Reglas de Consistencia (RC): Las reglas de consistencia se aplican de manera automatizada a todos los datos registrados en los aplicativos informáticos del SIS, con el objetivo de verificar su coherencia, determinando su

aceptación para el ingreso a la base de datos del SIS.

Los datos que no superan las reglas de consistencia, no son admitidos en la base de datos del SIS, y son publicadas por la OGTI en el portal web institucional, identificadas con su respectivo código de inconsistencia.

6.3.3 Aplicación de Reglas de Validación (RV): Están diseñadas para identificar las prestaciones que cumplen con el adecuado registro, los estándares de calidad en la atención, la oportunidad y la integralidad según la normatividad vigente, así como detectar aquellas que no cumplen estos criterios.

Las reglas de validación se aplican a la data registrada en los aplicativos informáticos del SIS, luego de superar las reglas de control de registro y las reglas de consistencia.

Como resultado de la aplicación de las reglas de validación, aquellos registros que no cumplan los criterios establecidos son observados y separados de la base de datos del SIS, para pasar por la Auditoría de seguimiento.

6.3.4 Las reglas de la Auditoría automatizada por sus características de variabilidad, adaptabilidad, interactividad y evolución continua, por el aprendizaje a partir de datos con machine learning, se formalizan con documentos formales de la GREP y serán publicadas en la página web institucional. De igual manera, la GREP establece los criterios para determinar valores atípicos.

6.4 Proceso de la Auditoría de pertinencia (PAP)

Es la Auditoría que realiza el auditor del SIS empleando para su desarrollo documentos normativos vigentes en la materia (guías,

normas técnicas de salud, protocolos de práctica clínica), así como la evidencia científica; que permita realizar la verificación de la pertinencia de la prestación de salud, registradas en los aplicativos informáticos del SIS.

La Auditoría de pertinencia tiene dos componentes:

i. Auditoría Electrónica de Prestaciones.
ii. Auditoría de Seguimiento.

6.4.1 Auditoría Electrónica de Prestaciones

6.4.1.1 Consiste en la Auditoría de los registros de prestaciones de salud ingresadas a la base de datos del SIS, en momento posterior a la Auditoría automatizada, es realizada por equipo auditor en el aplicativo informático del SIS, diseñado para este fin.

6.4.1.2 La Auditoria electrónica de prestaciones se realiza mensualmente a las prestaciones financiadas con el mecanismo de pago por prestaciones de salud.

6.4.1.3 Para su inicio, es necesario que haya finalizado el proceso de valorización de las prestaciones y que se haya cargado la información correspondiente a la producción mensual en el aplicativo. Una vez cumplido esto, la OGTI comunica formalmente a la GREP, quien determina el inicio de la Auditoría electrónica de prestaciones. Esta tiene una duración de cinco (05) días hábiles, con posibilidad de ampliación según necesidad. Todos los auditores de las UDR realizan esta actividad. El número de prestaciones a evaluar cada mes son comunicadas oportunamente por la GREP.

6.4.1.4 Los criterios de selección de la muestra, para la Auditoría Electrónica de Prestaciones son determinados por la GREP, así como los que

resulten del cálculo de “valores atípicos”. Estos criterios se basan en los principios de razonabilidad, pertinencia, objetividad, confiabilidad; mejora continua de la calidad y generación de valor, con el propósito de realizar una Auditoría justa y efectiva.

6.4.1.5 Luego de la Auditoría, el auditor asigna un código de observación a las prestaciones de salud (FUA) que no cumplan con los estándares de calidad, oportunidad e integralidad de acuerdo con la normatividad vigente. La lista de criterios de observación forma parte de esta Directiva y está contenida en el Anexo N° 01.

6.4.1.6 Las GMRs realizan el monitoreo diario de la ejecución de la Auditoría Electrónica de Prestaciones realizada por los auditores de seguros de las UDRs de su jurisdicción y toman las medidas necesarias a efecto de que el procedimiento se cumpla en el plazo establecido.

6.4.1.7 Cada mes de producción, mediante proceso automático implementado por la OGTI, se genera el reporte de resultados de la aplicación de las reglas de validación y de la Auditoría electrónica; incluye el número de las prestaciones no observadas y las prestaciones observadas con su respectivo código y detalle. Este reporte está disponible en el módulo informático de la auditoria electrónica de prestaciones a los dos (2) días hábiles siguientes de culminado la Auditoría.

6.4.1.8 La UDR remite el reporte de resultados a la DIRIS, DIRESA, GERESA, Unidad Ejecutora, o quien haga sus veces, en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles, después de la publicación del reporte en el

aplicativo informático del SIS, dicha acción debe ser monitoreada por la GMR correspondiente.

6.4.2 Auditoría de seguimiento

Es aquella Auditoría que verifica el levantamiento de observaciones identificadas en el proceso de Auditoría Automatizada (PAA) y la Auditoría Electrónica de Prestaciones.

6.4.2.1 La GREP comunica a las GMR el inicio y término de la Auditoría de seguimiento de las prestaciones de salud observadas.

6.4.2.2 La UDR/GMR comunica a la Unidad Ejecutora o IPRESS a través de la DIRIS/DIRESA/GERESA la fecha de inicio y término de la auditoría de seguimiento, a fin de que dispongan las acciones pertinentes para su subsanación.

La UDR es responsable de solicitar a la Unidad Ejecutora, IPRESS o DIRIS, DIRESA, GERESA, los datos de los usuarios designados como responsables de acceder al aplicativo informático del SIS creado para la subsanación de observaciones.

6.4.2.3 La auditoría de seguimiento se realiza en el respectivo aplicativo informático del SIS, de la siguiente manera:

a) El personal responsable de la IPRESS accede al aplicativo correspondiente y realiza la búsqueda del Formato Único de Atención (FUA) que se encuentra en estado observado, a través de la opción “VER FUA”; de esta forma puede visualizar el detalle de la(s)

observación(es) registrada(s).

b) La observación registrada debe precisar los criterios de observación, a fin de que los usuarios de la Unidad Ejecutora o IPRESS procedan a registrar en el mismo aplicativo informático, las correcciones o modificaciones en los campos observados o en aquellos relacionados directamente con la observación. Dependiendo de si se trata de una observación parcial o total, únicamente se permite la modificación de los campos observados, una vez ingresada la información, el sistema activa la función “validar los cambios de la solicitud”.

c) El levantamiento de observaciones requiere que se registre en el aplicativo informático, la información de sustento legible y escaneada, así como la declaración jurada original firmada por el médico auditor y/o el jefe de la oficina de seguros de la IPRESS que ha registrado la información, conforme al formato Anexo N° 03.

6.4.2.4 Finalizado el plazo de la auditoría de seguimiento, las observaciones registradas como observadas que no han sido levantadas, son rechazadas y no son admitidas en la base de datos del SIS.

6.4.2.5 La auditoría de seguimiento está a cargo del auditor de seguros del SIS; quien evalúa únicamente la documentación registrada en el aplicativo informático del SIS, durante la fecha de inicio y término de la auditoría de seguimiento dispuesta por la GREP.

6.4.2.6 El levantamiento de observaciones se realiza con base en la documentación escaneada, legible y pertinente que respalde la subsanación de las

observaciones formuladas. Se puede solicitar el levantamiento de observaciones a través de las siguientes formas:

i. Levantamiento individual: Levantamiento de observación en el FUA que tienen observaciones y sustento específico.

ii. Levantamiento grupal: Levantamiento de observación en el FUA con mismo motivo de observación y que puedan levantarse con el mismo sustento.

La declaración jurada se presenta según corresponda a las dos formas antes mencionados.

6.4.2.7 Culminada la evaluación se procede a registrar el resultado “RECONSIDERADO” para las que sean determinadas como válidas, o “RECHAZADO” en caso de no estar conforme, para lo cual debe consignar la razón que motiva el rechazo, según Anexo N° 04.

6.4.2.8 La GREP procede a realizar el cierre del periodo de Auditoría de seguimiento a través del aplicativo informático correspondiente, donde las prestaciones observadas que no hayan sido levantadas pasan a ser rechazadas de manera automática.

6.4.2.9 Una vez finalizado el cierre del periodo de la auditoría de seguimiento, el aplicativo notifica automáticamente a OGTI y a GNF para efectos del trámite de pago, según corresponda.

6.4.2.10 De ser necesario, la GREP puede establecer mediante documento oficial mecanismos especiales para el levantamiento de observaciones para los casos que consideren pertinentes, previo informe técnico.

6.5 Proceso de Auditoría Presencial (APRE)

Es aquella Auditoría en la que el auditor de seguros del SIS se desplaza físicamente a la IPRESS, para efectuar la revisión in situ, de los documentos físicos o electrónicos que sustentan la información registrada en los aplicativos informáticos del SIS, accediendo directamente a la historia clínica física o electrónica y estableciendo interacción con los profesionales responsables de la atención. Esta modalidad puede realizarse también durante el acto médico, permitiendo la verificación en tiempo real de la prestación brindada al asegurado. Esta puede ser inopinada o programada.

La Auditoría Presencial tiene dos componentes:

i. Auditoría concurrente
ii. Auditoría asistida por machine learning

6.5.1 Auditoría concurrente

Es la Auditoría que se lleva a cabo directamente en la IPRESS para auditar en tiempo real las prestaciones de salud en la atención brindada al asegurado SIS con el objetivo de identificar riesgos para mejorar la seguridad, calidad y el uso eficiente de los recursos.

6.5.1.1 La Auditoria concurrente es programada mensualmente por la GREP en todos los niveles de atención en las IPRESS donde se identifiquen condiciones de riesgo que afecten la calidad y oportunidad de las prestaciones de salud.

6.5.1.2 La ejecución de la Auditoría concurrente está a cargo de los auditores del SIS a nivel nacional, para lo cual se comunica a las IPRESS seleccionada con al menos dos (02) días hábiles de anticipación, en caso de auditorías programadas.

6.5.1.3 Una vez culminada la Auditoría concurrente, se redacta el acta correspondiente, según modelo (Anexo N° 05), en la cual los participantes tienen la opción de formular sus observaciones o comentarios, previo a su suscripción.

6.5.1.4 Como resultado de la Auditoría la UDR presenta un informe final a la GREP a través de la GMR correspondiente; esta última es responsable de monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos por la IPRESS.

6.5.1.5 La GMR consolida los informes de Auditoría concurrente de sus UDRs con sus respectivos anexos y emite un informe mensual a la GREP conteniendo las propuestas de control prestacional (Reglas de control de registro, reglas de consistencia o reglas de validación) de corresponder para mitigar o resolver los riesgos identificados.

6.5.2 **Auditoría asistida por Machine Learning**

Es aquella Auditoría que se realiza en prestaciones brindadas, que han superado la Auditoría automatizada y la Auditoría de pertinencia. Se enfoca en la validación de servicios prestados, mediante la revisión de historias clínicas físicas o electrónicas y sus respectivos FUAs físicos o digitales seleccionados empleando algoritmos de inteligencia artificial.

6.5.2.1 La GREP establece un modelo machine learning, incluyendo el uso de tecnologías informáticas e inteligencia artificial, para determinar la muestra de prestaciones, según Anexo N° 06 y la carga en el

aplicativo SIGEPS; asimismo determina las IPRESS del II y III Nivel de atención a auditar cada trimestre

6.5.2.2 Mediante proceso automático implementado por la OGTI se realiza la distribución de la muestra trimestral por cada IPRESS a auditar.

6.5.2.3 La UDR determina la fecha de las visitas, durante los tres (03) días hábiles posteriores a la disponibilidad de la muestra e informa a la GMR para su seguimiento y monitoreo.

6.5.2.4 La ejecución de las visitas se realiza los primeros quince (15) días de cada mes reservando la segunda quincena para el desarrollo de la Auditoría electrónica y otras actividades de la UDR

6.5.2.5 La UDR comunica a la DIRIS / DIRESA / GERESA / Unidad Ejecutora / IPRESS 48 horas antes del inicio de la Auditoría, la siguiente información:

a) Fecha y hora de inicio.
b) Nombre del auditor(es) SIS responsable(es).
c) La muestra de 60 historias clínicas, con el número de FUA correspondiente.

6.5.2.6 Se realiza la auditoría obligatoria de un mínimo de treinta (30) prestaciones.

6.5.2.7 La evaluación se inicia con la verificación de la existencia de las historias clínicas correspondientes a la muestra seleccionada. En caso de que la IPRESS no proporcione la historia clínica física o electrónica de una o más prestaciones, el auditor debe registrar dicho hallazgo en el acta de resultados (Anexo N° 07), considerarlo como un rechazo total.

6.5.2.8 Para cada historia clínica física o electrónica no localizada, el auditor procede a reemplazarla por otra historia clínica perteneciente a la misma muestra ampliada previamente entregada.

6.5.2.9 La inexistencia de una historia clínica física o electrónica de la muestra solicitada se consigna como hallazgo en el Acta de resultados. Dicha situación es comunicada al órgano correspondiente para el deslinde de responsabilidad administrativa disciplinaria

6.5.2.10 La inexistencia del FUA en físico o electrónico no afecta la continuidad del proceso, registrándose como hallazgo en el acta de resultados.

6.5.2.11 El auditor procede a la evaluación de la historia clínica física o electrónica y la información registrada en el SIGEPS, verificando el cumplimiento de los criterios consignados en el instructivo según Anexo N° 08, luego estos hallazgos son registrados en el módulo.

6.5.2.12 Como resultados se obtiene:

i. Prestaciones Conformes

Cuando el registro de la prestación en la historia clínica física o electrónica es concordante con lo registrado en el aplicativo SIGEPS.

ii. Prestaciones Rechazadas:

- Rechazo parcial: cuando la prestación no cumple con uno o más criterios de evaluación parcial.
- Rechazo total: cuando la prestación no cumple con alguno de los criterios de evaluación total.

6.5.2.13 Una vez realizada la visita de Auditoría, el auditor SIS tiene hasta 72 horas para culminar los registros en el módulo correspondiente.

6.5.2.14 Al finalizar la auditoría, se genera el acta de resultados desde el módulo correspondiente, la cual es firmada y sellada por duplicado, por el Auditor SIS responsable del proceso y por el representante designado de la IPRESS. La UDR presenta los Informes de Auditoria mensualmente a la GMR, quien consolida, monitorea y remite informe trimestralmente a la GREP, del mismo modo actúa en lo concerniente al cumplimiento de la implementación de recomendaciones por parte de las IPRESS.

6.5.2.15 La IPRESS visitada presenta un informe sobre la implementación de las recomendaciones emitidas, adjuntando la documentación sustentadora correspondiente, dentro de un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la culminación de la visita.

6.5.2.16 Se pueden determinar auditorias adicionales en cualquier momento a solicitud de la Jefatura Institucional o de la GREP.

VII. RESPONSABLES

7.1. La GREP es responsable de la implementación de la presente Directiva; así como de gestionar los aspectos operativos no contemplados en la misma.

7.2. Las Gerencias Macro Regionales son responsables de la coordinación, ejecución y monitoreo del cumplimiento de la presente Directiva.

7.3. Las GMR/UDR son responsables de cumplir las disposiciones de la presente Directiva en el marco de sus competencias.

7.4. La OGTI tiene la responsabilidad del soporte, diseño, desarrollo e implementación de los servicios electrónicos (aplicaciones, servicios electrónicos, entre otros) necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva; así como la automatización de las reglas de control de registro, reglas de consistencia y reglas validación establecidas por los órganos competentes.

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

8.1. Los aspectos no contemplados en la presente Directiva de Auditoría son precisados y detallados mediante documento emitidos por la GREP.

8.2. Los procesos de Auditoría de seguros pueden ser realizados por profesionales de la salud que no son médicos, en el ámbito de sus competencias, para las prestaciones realizadas por sus pares del mismo grupo profesional.

8.3. La GREP está facultada para implementar otros procesos de control diferentes a los establecidos en la presente Directiva de ser el caso, es establecido mediante documento formal, a fin de validar las prestaciones.

8.4. En caso la UDR no cuente con auditor de seguros, la GMR designa a un auditor de seguros de otra UDR de su jurisdicción o asume la ejecución de los procesos de Auditoría.

8.5. La Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones está facultada para disponer la ampliación los períodos de ejecución de las actividades de la Auditoría de seguros, así como para autorizar la no aplicación de alguna de las reglas de validación o consistencia en casos debidamente justificados ante la GMR.

8.6. La UDR comunica a la entidad evaluada los casos en que, como resultado de la Auditoría en seguros de las prestaciones de salud,

se evidencien riesgos en las prestaciones.

8.7. La negativa a presentar la información requerida por el auditor, así como la negativa a suscribir el acta emitida en el ejercicio de sus funciones, es comunicada al órgano correspondiente.

8.8. Las disposiciones, directivas, resoluciones u otros instrumentos normativos emitidos por la Unidad Ejecutora Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL) en materia de evaluación, supervisión o auditorias médicas, mantienen plena vigencia en el ámbito de sus competencias. Asimismo, FISSAL se encuentra facultado para aprobar e implementar nuevos mecanismos, lineamientos y procedimientos de auditoría que resulten necesarios para el cumplimiento de sus funciones, en concordancia con la normatividad vigente y con sus atribuciones institucionales.

8.9. Las acciones que se opongan a la presente Directiva quedan sin efecto.

IX. ANEXOS

- **Anexo N° 01:** Criterios de Observación - Auditoria Electrónica de Prestaciones.
- **Anexo N° 02:** Motivos de levantamiento de observaciones.
- **Anexo N° 03:** Declaración jurada de veracidad de la información.
- **Anexo N° 04:** Criterios para la subsanación de observaciones de las prestaciones de salud.
- **Anexo N° 05:** Acta de Auditoria concurrente.
- **Anexo N° 06:** Algoritmo y criterios de selección de la muestra del proceso de la Auditoria asistida por Machine Learning.
- **Anexo N° 07:** Acta de resultados del proceso de la Auditoria asistida por Machine Learning.
- **Anexo N° 08:** Instructivo para el desarrollo de la auditoría asistida por Machine Learning.
- **Anexo N° 09:** Flujograma de la Auditoria de Seguros y de Control de las Prestaciones de Salud (ASECO).

ANEXO N° 01

CRITERIOS DE OBSERVACIÓN - AUDITORIA ELECTRÓNICA DE PRESTACIONES

TIPO DE OBS.	DESCRIPCIÓN	COD.
OBSERVACIÓN TOTAL	Se considera observación total cuando la prestación no es admitida por el SIS, es decir que ninguno de sus consumos asociados (insumos, medicamentos o procedimientos) puede ser reconocido ni financiado.	OT
OBSERVACIÓN PARCIAL	Se considera observación parcial cuando la prestación es admitida, pero incluye consumos que no pueden ser justificados.	OP

COD.	CRITERIO DE OBSERVACIÓN	DESCRIPCIÓN
OT1	Concordancia entre diagnóstico y tratamiento	Verifica si el tratamiento indicado corresponde al diagnóstico registrado
OT2	Concordancia entre diagnostico principal y código de servicio registrado	Verifica que el código de servicio registrado corresponda al diagnóstico principal de la atención
OT3	Responsable de atención no acorde a código de servicio, diagnóstico o tratamiento	Se evalúa si el código de servicio, diagnóstico o tratamiento guardan relación con el responsable de atención
OT4	Prestación no forma parte del plan de beneficios según tipo de seguro SIS	Evalúa que los diagnostico o el consumo este dentro de la cobertura del SIS (plan de beneficio)
OT5	Ningún componente de la prestación cumple con las condiciones necesarias para ser reconocidas por el SIS	Todos los registros de los procedimientos, medicamentos e insumos reportados están observados

OP1	Falta de concordancia entre procedimiento (CPMS) y código de servicio	Verifica si el procedimiento CPMS registrado corresponde al código de servicio asignado
OP2	Procedimiento (CPMS) no acorde a nivel de atención de la IPRESS	Evalúa si el procedimiento o examen de apoyo al diagnóstico, corresponde al nivel de atención de la IPRESS
OP3	Procedimiento (CPMS) no acorde a Diagnostico	Evalúa si los exámenes o procedimientos guardan relación lógica y clínica con el diagnóstico.
OP4	Duplicidad o exceso de procedimientos	Evalúa si hay duplicidad o registro innecesario de procedimientos similares.
OP5	Medicamento/ insumos no acorde a Diagnósticos	Evalúa si los medicamentos e insumos guardan relación lógica y clínica con el diagnóstico.
OP6	Uso de medicamentos /insumos no justificados	Evalúa: - Registro innecesario o exceso de medicamentos o insumos - Los que son considerados como no parte del gasto variable Medicamento no PNUME con indicación fuera de ficha técnica
OP7	Insumos o medicamentos están incluidos en la estructura cuali-cuantitativa de los procedimientos (CPMs)	Verifica si los insumos registrados están incluidos como parte del procedimiento.

ANEXO N°02

MOTIVOS DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

a) Datos digitados en el aplicativo informático SIS diferentes a los registrados en el FUA en físico, con atención adecuadamente registrada y sustentada en la historia clínica, correspondiente a una prestación con manejo adecuado y según lo estipulado en Guía de Práctica Clínica, la mejor evidencia científica disponible y/o normatividad vigente.

b) Omisión de datos en la digitación de la prestación y en el aplicativo informático SIS, con la atención adecuadamente registradas y sustentada en el FUA en físico y en la historia clínica, correspondiente a una prestación con manejo adecuado y según lo estipulado en GPC, evidencia científica disponible y/o normatividad vigente.

c) Registros errados en el FUA en físico que condicionaron un inadecuado registro de la prestación en el aplicativo informático SIS, pero con procedimientos, actividades, medicamentos, cantidades y otros ítems debidamente brindados y respaldado en la historia clínica, correspondiente a una prestación con manejo adecuado y según lo estipulado en las GPC, evidencia científica disponible y/o normatividad vigente.

d) Desacuerdo del prestador con el motivo de la observación, sin requerir modificación del FUA físico ni del registro en el aplicativo informático SIS. En estos casos, se deberá adjuntar sustento documentado basado en evidencia científica y/o normativa vigente que justifique expresamente el registro observado. Esta información será evaluada según corresponda al caso.

ANEXO N°03

DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Yo……con cargo y/o responsable: …… con D.N.I N°

Declaro, bajo juramento, que la información registrada en el aplicativo de levantamiento de observaciones, se realiza por el siguiente motivo…….. (indicar el motivo, según Anexo N° 02 de la Directiva); asimismo declaro que, la documentación de sustento correspondiente, es veraz, completa y ha sido elaborada con integridad.

Asimismo, declaro que conozco y me comprometo al cumplimiento de los principios de transparencia, legalidad e integridad establecidos en el marco de la norma ISO 37001 – Sistema de Gestión Antisoborno, por lo que me abstengo de ofrecer, prometer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier tipo de ventaja indebida que pueda influir en las decisiones del auditor del Seguro Integral de Salud o cualquier funcionario relacionado.

De comprobarse fraude, falsedad o cualquier forma de conducta que constituya una ventaja indebida entre esta IPRESS y los auditores del SIS, el Seguro Integral de Salud procede conforme a lo dispuesto en el artículo 34.3 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N.º 005-2019-JUS, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas que correspondan.

……de……del 202…….

Huella digital

Firma del Declarante
Sello con nombre de la entidad y cargo

ANEXO N°04

CRITERIOS PARA LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DE LAS PRESTACIONES DE SALUD

A. CRITERIOS DE RECHAZO

1. Escaneado del FUA original con enmendaduras, borrones, omisión de datos o llenado inadecuada según norma.
2. Levantamiento de observaciones registrado en el aplicativo sin el sustento respectivo según corresponda.
3. Documentos de sustento según corresponda con letra ilegible o que no se encuentren llenado de acuerdo a la normatividad vigente o se visualiza información agregada (interlineado, con diferente letra o tinta).
4. Otros que considere.

B. DE LA EVALUACIÓN DEL SUSTENTO

El sustento debe demostrar que rebate el motivo de observación para ello la IPRESS debe adjuntar el sustento basado en la mejor evidencia científica y/o evidencia normativa (Normas MINSA, protocolos institucionales aprobados y oficializados, GPC) y/o documentos emitidos por el SIS, según sea el caso, que justifique en forma expresa el registro o prestación que fue observada, asimismo, debe demostrar concordancia de la prestación brindada acorde al diagnóstico, tratamiento y procedimientos realizados.

C. NO SON MOTIVOS DE SUBSANACIÓN DE PRESTACIONES

1. Cualquier motivo que intente avalar una prestación brindada en forma inadecuada. Por ejemplo, desabastecimiento de medicinas y/o insumos o que se pretenda justificar un tratamiento incompleto.
2. Asimismo, no se considera como válidas aquellas prestaciones con FUA sin sellos, firmas y/o huellas, según corresponda.

ANEXO N° 05

ACTA DE AUDITORIA CONCURRENTE

Reunidos en la ciudad de _____el ___de _____del 202_ a las _____ _____horas, se reúnen en las instalaciones del _____los siguientes*:*

Participantes	**Cargo**

Agenda:

Presentación de resultados de la auditoria concurrente.

Desarrollo:

Se describirán las actividades previas al desarrollo de la auditoria.
Se describirá si la IPRESS cumplió con las condiciones solicitadas y con la documentación solicitada antes del inicio de las auditorias.
Se describen las incidencias que pudieran acontecer que afectar el desarrollo normal de las actividades agendadas.
Se describe brevemente sobre el desarrollo de las actividades realizadas

Resultados de la auditoria:
Se describen las principales observaciones encontradas:

Código de servicio	N° Historia clínica	N° FUA	Detalle de la Observación

Como resumen cuantitativo de las observaciones encontradas se propone la elaboración de la siguiente tabla:

PF, DM o PS	* Cantidad dispensada por farmacia	N° FUA	Cantidad registrada en el FUA	N° Historia clínica	Cantidad registrada en HCL

* Fuente de información: Sistema informático de farmacia de la IPRESS.
PF, DM o PS: Producto Farmacéutico, dispositivo médico, producto sanitario.

Siendo las _____, firman dando fe de la auditoria efectuada y hallazgos encontrados.

Participantes	Cargo	Firma

ANEXO N° 06

ALGORITMO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA DEL PROCESO DE AUDITORIA ASISTIDA POR MACHINE LEARNING

1. **Extracción de la muestra por modelo de machine learning:**

   El modelo de clasificación para obtener la muestra es ejecutado por el equipo técnico de la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones. La muestra se extrae desde la base de datos del registro de prestaciones del SIS correspondiente a la etapa final de cada periodo de producción valorizada posterior a la supervisión electrónica, considerando únicamente prestaciones que no hayan sido observadas previamente por el proceso de Auditoria automatizada ni por la Auditoria electrónica de prestaciones.

2. **Metodología de Extracción de Muestra:**

   2.1 Algoritmo de Aprendizaje Supervisado (XGBoost): Este algoritmo genera la muestra auditable y se desarrolla según los siguientes pasos:

   a) Selección y entrenamiento del modelo XGBoost utilizando datos históricos relevantes. Se emplea métricas como F1-score y Recall para asegurar la eficacia del modelo en la identificación de casos auditables.

   b) El entrenamiento del algoritmo se realiza con datos etiquetados para determinar la capacidad predictiva del modelo, garantizando así la validez y confiabilidad del proceso.

   c) El modelo es sometido a procesos rigurosos de validación para asegurar su aplicabilidad consistente en diferentes contextos operativos. Se utiliza específicamente el modelo XGBoost para identificar registros susceptibles de no conformidad en los procesos de auditoría desde los años 2019 hasta la actualidad.

d) Las variables utilizadas para entrenar el algoritmo incluyen: edad, sexo, servicio, valor del FUA, procedimientos, cantidad de procedimientos, valor FUA Insumos, cantidad de insumos, valor FUA medicación, cantidad de medicamentos, costo observado en procedimientos, costo observado en insumos, costo observado en medicación, diagnóstico principal, hospitalización, estancia hospitalaria, identificación de IPRESS, además del consumo del paciente con su cantidad y si es descontado o no.

3. Proceso de generación y selección de la muestra:

El conjunto de prestaciones en producción es clasificado mediante el modelo XGBoost y segmentado por cada Gerencia Macrorregional (GMR). La selección considera la fecha de atención, manteniendo un intervalo de un trimestre entre la prestación y la supervisión. Tras la clasificación, cada prestación recibe una etiqueta que la identificará según el riesgo de no conformidad. Finalmente, a las prestaciones clasificadas con alta probabilidad (riesgo mayor de no conformidad) se les realiza una priorización basada en mayor riesgo, para determinar eficazmente la muestra asignada a los auditores.

ANEXO N° 07

ACTA DE RESULTADOS DEL PROCESO DE AUDITORIA ASISTIDA POR MACHINE LEARNING

Nombre de la IPRESS: _____

DIRIS / DIRESA / Unidad Ejecutora: _____

Jefe de la Oficina de Seguros o Representante de la IPRESS: _____

Responsable del SIS (auditor SIS): _____

Número de prestaciones evaluadas: _____

Fecha _____ **Hora** _____

N°	N° DE HISTORIA CLÍNICA	FORMATO ÚNICO DE ATENCIÓN			EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SALUD (Marcar X)			Criterio de rechazo	** Detalle de Rechazo total	** Detalle de Rechazo parcial
		Código RENIPRESS	Lote	Número	Conforme	Rechazo total	Rechazo parcial			
1										
2										
9										
30										
* Muestra ampliada										
1										
2										
9										
30										

* Este campo corresponde a las prestaciones de la muestra ampliada utilizada.

** Detalle cualitativo del rechazo.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Prestaciones conformes _____

Prestaciones con rechazo total _____

Prestaciones con rechazo parcial _____

Total de prestaciones evaluadas _____

Cantidad de Historias Clínicas no entregadas por la IPRESS _____

Cantidad de FUAs no entregados por la IPRESS _____

Números de los FUAs que no se encuentran en el momento de la Auditoria.

Resumen de la auditoria y Recomendaciones

El plazo de implementación de recomendaciones es de 20 días hábiles a partir de la culminación de la auditoria en la IPRESS.

Auditor SIS 1 **RNA:**.....	**Auditor SIS 2** **RNA:**	**Jefe / Responsable /Encargado**

ANEXO N° 08

INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA ASISTIDA POR MACHINE LEARNING

I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN

A. EVALUACIÓN PARA RECHAZO TOTAL

REGISTRO Y CONCORDANCIA DE LAS FUENTES DE VERIFICACIÓN HISTORIA CLÍNICA Y SIGEPS

Criterio	Descripción
A-1	No se dispone de la historia clínica
A-2	No hay evidencia la prestación de salud en la historia clínica
A-3	No se verifica la concordancia de los datos generales del asegurado y la fecha de atención en la historia clínica y el SIGEPS
A-4	No se verifica la concordancia de los diagnósticos consignados entre la historia clínica y el SIGEPS, los diagnósticos deben estar debidamente sustentados en la historia clínica
A-5	No se verifica que el código de servicio registrado en el SIGEPS corresponda a la atención registrada en la historia clínica
A-6	No se ha podido comprobar que la atención haya sido realizada por el profesional de salud que corresponde (como médico especialista, médico general u otro profesional o técnico), según el tipo de prestación y la categoría de la IPRESS. Para esta verificación, se considera la coincidencia de los datos del personal, así como la firma y el sello de quien brindó la atención, en los documentos correspondientes.

Nota: La historia clínica puede ser física o electrónica.
La inexistencia del FUA físico no afecta la continuidad del proceso de auditoría, este hallazgo se registra en el acta.

B. EVALUACIÓN PARA RECHAZO PARCIAL

VERIFICACIÓN Y CONCORDANCIA ENTRE LAS FUENTES

B-1	**Diagnóstico, terapéutica y procedimientos:** No concordancia del registro de los procedimientos, los diagnósticos y/o la terapéutica entre el SIGEPS y la historia clínica.
B-2	**Exámenes de apoyo al diagnóstico:** No concordancia o inexistencia de los exámenes de apoyo al diagnóstico indicados (laboratorio, patología clínica, diagnóstico por imágenes y anatomo-patológicos) entre el SIGEPS y la historia clínica: incluye la verificación de la existencia de los resultados en la historia clínica.
B-3	**Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios**: En relación con los medicamentos, se observa falta de concordancia entre la prescripción, la presentación y la cantidad registrada en el SIGEPS, en comparación con lo documentado en la historia clínica. Asimismo, debe verificarse el Kardex u otro registro clínico que permita confirmar la correspondencia entre la información consignada en el SIGEPS y lo efectivamente administrado al paciente según la historia clínica."
B-4	Cuando en el SIGEPS existan registros de códigos SISMED incluidos en la estructura cuali-cuantitativa del procedimiento efectuado

Nota: La historia clínica puede ser física o electrónica.
La inexistencia del FUA físico no afecta la continuidad del proceso de auditoría, este hallazgo se registra en el acta.

i. Se verifica el estado de cuenta del consumo en procedimientos, exámenes de apoyo al diagnóstico y PF, DM y PS.

   El procedimiento corresponde al diagnóstico asignado, y código de servicio registrado, al nivel de atención de la IPRESS y guarda relación con el registro de la historia clínica, así como verifica que no exista duplicidad, o registro innecesario de procedimientos similares o que se encuentren incluido dentro de otro procedimiento realizados en una misma sesión al paciente.

ii. En relación al criterio de B-3, tener en cuenta que en el caso de uso de medicamentos No PNUME se debe contar con el documento de aprobación del comité farmacoterapéutico correspondiente o con la Evaluación de Tecnología Sanitaria (ETS) de corresponder.

II. PAUTAS MÍNIMAS PARA EL LLENADO DEL ACTA DE RESULTADOS DEL PROCESO DE AUDITORIA ASISTIDA POR MACHINE LEARNING

1. En el módulo de auditoria asistida por machine learning "Registro de Evaluación de las Prestaciones":

a. Se selecciona el "Criterio de rechazo"

b. En "Detalle de rechazo total" se describe las características cualitativas del rechazo

c. En "Detalle de Rechazo parcial" se describe las características cualitativas del rechazo parcial.

d. Las características del rechazo deben ser descritas durante la evaluación en el aplicativo, especificando, por ejemplo: nombre del medicamento, concentración del medicamento, pertinencia del medicamento con el diagnostico, discordancia del procedimiento con los insumos utilizados, de ser el caso y la discordancia entre diagnósticos con insumos, medicamentos y/o procedimientos.

2. En el Resumen del acta de resultados, debe contener:

a. Los hallazgos de la auditoria asistida por machine learning

b. El/los números de la historia clínica de la prestación no entregadas por la IPRESS

c. El/los números de FUAs no entregados por la IPRESS

d. Recomendaciones detalladas y el plazo de su implementación de 20 días hábiles.

3. Este Anexo es firmado por el auditor SIS responsable del proceso y el Jefe/Director de la IPRESS o encargado, o responsable de la Dirección/Oficina de seguros de la IPRESS o algún responsable delegado por estos, con lo que se dará por concluida la etapa de ejecución.

III. ACRONIMOS

1. ETS: Evaluación de Tecnología Sanitaria
2. INS: Instituto Nacional de Salud
3. DCI: Denominación Común Internacional
4. PNUME: Petitorio Nacional Único de Medicamentos.

ANEXO N° 09

FLUJOGRAMA DE LA AUDITORÍA DE SEGUROS Y DE CONTROL DE LAS PRESTACIONES DE SALUD (ASECO)

